

用量过大或同时服用普萘洛尔、四环素可引起低血糖危象;用口服降糖药治疗的糖尿病人,若同时服用磺胺药、保泰松、双香豆素等均可因促使胰岛素分泌,减少胰岛素分解而致低血糖危象。

7 垂体危象 在给原有垂体功能减退者用苯二氮䓬类药物,如地西泮(安定)、氯氮䓬、去甲羟安定、氯羟安定、硝基安定、氟硝安定、氟安定、三唑安定及艾司唑仑时,由于这类病人对该类药物非常敏感,常可进一步降低垂体功能而发生垂体危象。

8 氨茶碱危象 用氨茶碱治疗肺源性心脏病哮喘时,

• 不合理处方分析 •

环孢菌素 A 的药物相互作用(一)

王少华 陈安进

266011 青岛市市立医院临床药理基地

环孢菌素 A(CsA, 山地明, 环孢素)是一种免疫抑制剂,可逆地特异作用于淋巴细胞,可延长同种异体器官移植的存活时间,抑制细胞介导的免疫反应,尚能抑制淋巴因子的合成与释放,阻断淋巴细胞生长周期中的 G_0 期和 G_1 早期阶段,不抑制红细胞生成,亦不影响吞噬细胞功能。临床用于预防和治疗同种异体器官移植后的排异反应或骨髓移植后的移植物抗宿主病(GVHD),以及经其他免疫抑制剂治疗无效的狼疮肾炎、难治性肾病综合征等自身免疫性疾病。环孢菌素 A 与氨基糖苷类抗生素、大环内酯类抗生素、口服避孕药、钙离子通道阻断药、抗癫痫药等多种药物有相互作用。对其临床不合理配伍情况举例说明如下。

处方 1 山地明与林可霉素

盐酸林可霉素 $0.6g \times 10$ $0.6g$ bid iv

山地明 $50mg \times 50$ $150mg$ bid po

(视病情调整剂量)

分析:有研究表明,肾移植患者合并应用林可霉素和环孢素,使肾毒性增加,用氨苄西林(氨苄青霉素)替代林可霉素肾毒性发生率降低。

处理方法:两药应尽量避免合用以减少肾毒性,可用氨苄青霉素等与环孢素合用肾毒性低的药物替代林可霉素;如确需联用,应密切监测肾功能变化,一旦发现肾脏损害,应立即停药。

处方 2 山地明与妥布霉素

中国知网 <https://www.cnki.net>
硫酸妥布霉素 $80mg$ $80mg$ qid iv

可出现惊厥、震颤、心动过速、心律失常、血压下降、昏迷甚至突然死亡;若静脉推注氨茶碱过快,当血药浓度 $>20\mu g/ml$ 时,可发生心跳骤停而死亡。

9 溶血危象 在给葡萄糖 6-磷酸脱氢酶缺乏的病人用伯氨喹、奎尼丁、非那西丁、磺胺类药物时可引起溶血危象;另外用硝基甲苯、铅制剂也可直接损害红细胞而引起溶血危象。

(256609 山东省滨州卫生学校 金仲品)

(2000-07-19 收稿 2000-08-20 修回)

[陈 磊 编发]

山地明 $50mg \times 50$ $150mg$ bid po

(视病情调整剂量)

分析:环孢素与妥布霉素均有较强的肾毒性,有报道两药联用肾毒性发生率增高。环孢素与庆大霉素、新霉素等其他氨基糖苷类抗生素合用时,均增加其肾毒性。

处理方法:应避免两药合用,可用其他抗生素替代妥布霉素。如确须联用,应密切监测肾功能变化,如有异常,应立即停药。应同时监测妥布霉素血药浓度,如其峰浓度超过 $12\mu g/ml$ 和谷浓度超过 $2\mu g/ml$ 时易出现毒性反应。

处方 3 山地明与红霉素

红霉素 0.125×24 $0.25g$ qid po

山地明 $50mg \times 50$ $150mg$ bid po

(视病情调整剂量)

分析:使用环孢素的患者,合用红霉素后,其血清环孢素水平显著升高,并由此引起急性肾毒性和肝毒性。此机制尚未完全明确,可能为红霉素减少肝脏对环孢素的代谢,也可能是红霉素增加了环孢素在消化道的吸收。

处理方法:环孢素与红霉素的相互作用确定无疑,若须联合用药,必须密切监测血清环孢素浓度,减少其给药剂量;也可以通过静脉给予环孢素,避免红霉素增加环孢素的胃肠道吸收。

(未完待续)

(2000-09-18 收稿)

[于小雪 编发]